Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa

Rua Buenos Aires, 919 - Bairro: Centro - CEP: 98780735 - Fone: (55) 3512-5837 - Email: frsantrosa1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005825-51.2024.8.21.0028/RS

AUTOR: GIANNA KETTNER DE CARVALHO

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I- RELATÓRIO:

GIANNA KETTNER DE CARVALHO ajuizou "ação cominatória c/c obrigação de fazer e tutela de urgência" em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**. Narrou ser portadora de neoplasia maligna de mama bilateral (CID C50.9), tendo sido recomendado o uso do medicamento Ribociclibe 200mg, 3 comprimidos uma vez ao dia, por 21 dias, a cada 28 dias, por tempo indeterminado. Discorreu acerca do direito que entende ser aplicável. Em sede de tutela de urgência, postulou a imediata concessão do fármaco, conforme prescrição médica. No mérito, pleiteou a procedência da ação, para tornar definitiva a obrigação de fornecimento do medicamento, bem como para condenar o IPE ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade judiciária (evento 1, INIC1).

A inicial foi recebida e a gratuidade judiciária deferida. Ainda, a tutela de urgência foi deferida, determinando-se ao IPERGS o fornecimento do medicamento postulado (evento 5, DESPADEC1).

O requerido apresentou contestação (evento 34, CONT1). Asseverou que o medicamento postulado não se encontra elencado no protocolo oncológico do IPE Saúde para o tratamento da enfermidade apresentada. Discorreu acerca do sistema de saúde dos servidores públicos estaduais e da sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde - FAS. Ofertou outros medicamentos para tratar a enfermidade, com cobertura pelo IPE. Referiu não haver comprovação da existência de nexo causal entre eventual ação/omissão do IPE e os danos morais supostamente sofridos. Postulou a improcedência da demanda, com condenação do autor ao pagamento dos ônus de sucumbência.

No decorrer da ação judicial, foram realizados diversos bloqueios de valores, determinando-se à parte autora que, caso houvesse necessidade de outros bloqueios, formulasse pedido em expediente de cumprimento provisório de sentença, para possibilitar o regular andamento do feito (evento 178, DESPADEC1).

Houve réplica (evento 189, RÉPLICA1).

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendiam produzir (evento 197, ATOORD1).

O IPE-Saúde postulou a elaboração de nota técnica (evento 204, PET1), o que foi deferido (evento 211, DESPADEC1), porém, a solicitação foi devolvida pelo NatJus nacional, sob o argumento de que não se trata de ação em desfavor do SUS (evento 218, EMAIL1).

É o relatório.

Decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO:

<u>Do Direito à Saúde</u>:

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e, em seu artigo 6º, *caput*, que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o artigo 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu artigo 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

<u>Da necessidade do tratamento</u>:

No caso em análise, a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Ribociclib foi deferida (evento 5, DESPADEC1).

Restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.

A <u>necessidade</u> está evidenciada pela documentação médica acostada aos autos, especialmente no evento 1, LAUDO18 e evento 1, EXMMED23, indicando possuir a parte autora diagnóstico de **neoplasia de mama bilateral EC IV - doença metastática** (CID 10 C50.9) e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento Ribociclib. Da mesma

forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível da medicação poderá evitar a progressão da doença, o envolvimento de órgãos vitais e até mesmo o óbito:

PATRÍCIA MARKS
ONCOLOGIA CLÍNICA

LAUDO MÉDICO

Paciente Gianna Ketnner de Carvalho, 43 anos, é portadora de CID C50.9, neoplasia de mama bilateral EC IV - doença metastática (linfoadenomegalias, metástases ósseas, nódulos pulmonares), com doença perfil Luminal B.

Tem indicação, baseada nas diretrizes mais atuais de tratamento, de iniciar tratamento com Ribociclib (Kisqali) 200mg – 3comp 1x dia por 21 dias a cada 28 dias, enquanto tiver resposta ao tratamento

Estudo do New England Journal of Medicine demonstrou aumento significativo de ganho de sobrevida livre de progressão e sobrevida global com o uso da medicação [N Engl J Med 2020;382:514-24].

O medicamento Ribociclib está indicado e regulamentado em bula para uso no Brasil pela Agência Nacional de Saúde, assim como pelas diretrizes Americanas e Européias; entretanto, a operadora IPERGS, não disponibiliza a referida medicação para a paciente.

Não há, no momento, nenhuma outra medicação disponível pela operadora que o substitua com igual benefício clínico e de ganho de sobrevida e qualidade de vida.

Visan Clínica Médica
55 2120-4030
55 99164-3668
Av. Rio Grande do Sul, 827
Santa Rosa-RS

CREMERS 36982 RQE 32006

PATRÍCIA MARKS
ONCOLOGIA CLÍNICA

O não uso do referido medicamento e também o atraso no início do tratamento, pode acarretar progressão da doença com envolvimento de outros órgãos vitais como cérebro, fígado, piora das lesões pulmonares e osseas, apresentar dor óssea intratável, com compressão medular e perda de movimentos, piora da qualidade de vida (e da falta de ar) e óbito, sendo, portanto, URGENTE a necessidade de início do tratamento, devido ao risco de vida para a paciente, o mais precocemente possível.

13/06/2024

Patricia Marks
Oncologia Clínica
CREMERS 36982

Dra Patricia Marks
CRM 36982

Ainda, o laudo médico atualizado indica que a paciente está fazendo uso da medicação pleiteada, com boa resposta ao tratamento, indicando-se a manutenção deste, por tempo indeterminado:

PATRÍCIA MARKS
ONCOLOGIA CLÍNICA

Laudo Médico

Pacuntie Gianna K. Carvalho é portadora neoplasia mama - CID C509, em quadro paliativo (metástases ósseas e pulmonares). Está em tratamento com Ribociclib, com ótima resposta ao tratamento, com indicação de manter o mesmo até progressão.

Dra. Patricia Marks
Médica Oncologista Clínica
CREMERS 36982

02/03/25

Viena Clínica Médica
55 2120-4030
55 99164-3668
Av. Rio Grande do Sul, 827
Santa Rosa-RS

CREMERS 36982 RQE 32006

Com efeito, a médica assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPÊ-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06/04/2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPÊ-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPÊ-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (artigo 4º, §1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pela médica assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade, conforme entendimentos exarados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em situações análogas:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2.* ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso,***

__tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado__. 3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022). (Grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RIBOCICLIBE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Complementar Estadual n. 12.134/2004, atualizada pela Lei n. 15.145/2018, prevê que o Plano IPE-SAÚDE integra atendimentos médicos, hospitalares e os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção de doença e promoção da saúde. 2. A Resolução n. 021/1979, que regulamenta a Assistência Médico-Hospitalar do Instituto, estabelece que o plano cobrirá os atendimentos médicos hospitalares e os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento, incluindo a especialidade de oncologia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado. 4. __O laudo médico comprova que a parte autora é portadora de neoplasia maligna de mama com metástases ósseas, sendo o medicamento postulado imprescindível para aumentar sua sobrevida, sob risco de progressão da doença e morte. 5. A negativa de fornecimento do medicamento por não estar incluído no protocolo utilizado pelo Instituto não pode prosperar, pois o tratamento pleiteado está incluído na especialidade de oncologia, com previsão expressa de fornecimento pelo IPE-Saúde__. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50006546820248210043, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 06-10-2025). (Grifou-se).

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do medicamento postulado ao tratamento de sua patologia, imperiosa a procedência da ação, neste ponto.

Dos danos morais:

A responsabilidade civil do Estado (Poder Público em sentido amplo) é a obrigação imposta ao erário de reparar os danos causados a terceiros pelos seus agentes públicos, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las.

Na hipótese de falha na prestação dos serviços públicos, por conduta omissiva, tal obrigação de indenizar se baseia na Teoria da Culpa Administrativa, a qual procura desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do agente público individualizado, vinculando-a ao serviço público em si. Distingue-se, de um lado, a culpa individual do agente e, de outro, a culpa anônima do serviço público. Tal teoria se aplica nas situações de omissão estatal, ou seja, falha na prestação do serviço público (não prestado, mal prestado ou prestado com atraso).

A jurisprudência do STF e do STJ é no sentido de que a responsabilidade civil no caso de omissão estatal também é objetiva. Isso porque o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, determina a responsabilidade objetiva do Estado sem fazer distinção se a conduta é comissiva (ação) ou omissiva, não cabendo ao intérprete estabelecer distinções onde o texto constitucional não o fez. Dessa forma, a responsabilidade objetiva estatal engloba tanto os atos comissivos como os omissivos.

Por conseguinte, a fim de caracterizar a responsabilização civil do Poder Público, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: **(i)** ação ou omissão administrativa; **(ii)** ocorrência do dano; e **(iii)** nexo causal entre o dano e a conduta administrativa.

No caso em análise, **não estão presentes os requisitos**, uma vez que não comprovou a parte autora seus elementos, limitando-se a alegações genéricas e abstratas. Outrossim, a negativa ou o atraso no fornecimento do tratamento não acarreta, por si só, danos a serem ressarcidos, sejam materiais ou morais.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IPE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1076 DO STJ. **1. A negativa de cobertura, por si só, não configura dano moral passível de indenização, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo e relevante, não ocorrido no presente caso, em que a parte autora realizou o tratamento requerido a partir da concessão da tutela de urgência.** 2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema nº 1.076 do STJ, firmou a seguinte tese: "[...] ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." 3. Assim, nas demandas em que se discute direito à saúde, como o caso em tela, conforme precedentes posteriores à publicação do tema supracitado, a Corte Superior tem entendido como correta a incidência do item "ii" alínea "a", por entender que são casos com proveito econômico inestimável. 4. Quanto aos honorários, a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é adequada em ações de saúde, nas quais o valor do direito não é mensurável economicamente, mantendo-se a verba arbitrada. 5. Caso concreto em que, observados os parâmetros do art. 85, § 2º e 3º, do CPC, sobretudo a jurisprudência em torno do tema, a baixa complexidade da causa e a ausência de dilação probatória, mostra-se justo e suficiente para o caso concreto, por meio de apreciação equitativa, o montante arbitrado na origem a título de honorários sucumbenciais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50008694320198210100, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diego Carvalho Locatelli, Julgado em: 25-04-2025). (Grifou-se).*

*APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). IPÊ-SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. **1. A negativa de cobertura, isoladamente, não ultrapassa o âmbito dos meros aborrecimentos, tampouco consubstancia violação dos direitos da personalidade. Para que tal conduta represente dano moral indenizável, ela deve estar acompanhada de prova da ocorrência de prejuízo digno de reparação. In casu, permanece ausente demonstração de que a autora tenha sofrido abalo psicológico ou agravamento do seu estado de saúde em razão da negativa de fornecimento do medicamento pleiteado.** 2. Esta Corte vem proclamando a possibilidade de arbitramento dos honorários por equidade em demandas como a presente, que versam sobre o direito à saúde, justamente pelo seu valor inestimável. Por outro lado, viável que a verba honorária seja majorada para o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 50043025620238210022, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 11-11-2024). (Grifou-se).*

Acrescento, em relação aos danos de caráter moral, serem exigidas circunstâncias particulares, inexistentes ou, pelo menos, não demonstradas no caso dos autos, quais sejam: prova cabal da piora do estado de saúde, seja físico ou emocional, em razão da negativa ou do atraso no fornecimento do tratamento. Não se trata, pois, de dano *in re ipsa.*

Assim, inexistindo prova dos alegados danos, não vislumbro dever indenizatório.

III- DISPOSITIVO:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos formulados por **GIANNA KETTNER DE CARVALHO** em face do **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, para **CONDENAR** o réu a fornecer à autora o medicamento Ribociclibe 200mg, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a necessidade, nos termos da prescrição da médica assistente, tornando definitiva a tutela de urgência concedida no evento 5, DESPADEC1.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Porém, a exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade judiciária deferida no evento 5, DESPADEC1.

O demandado deverá arcar com os 70% remanescentes, no que se refere às **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC) e aos **honorários sucumbenciais** aos procuradores do autor, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação, com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil.

Agendada a intimação das partes.

Publicação e registros eletrônicos.

Interposto(s) recurso(s), caberá ao cartório, mediante ato ordinatório, conceder vista dos autos à parte contrária para contrarrazões e, na sequência, remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado.

Havendo custas pendentes, encaminhe-se a guia à Central de Cobranças (CC). Saliento que, conforme Ato nº 021/2017-P, a cobrança das custas finais do processo será integralmente realizada pelo Departamento de Receita-Serviço de Cobrança, do Tribunal de Justiça, cabendo ao Cartório a comunicação ao aludido órgão acerca da pendência de custas, mediante remessa da guia à Central de Cobranças (CC), na forma disponibilizada no sistema, caso a parte sucumbente não seja beneficiária da gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA LIMA MEDEIROS TREVISOL, Juíza de Direito**, em 20/10/2025, às 17:19:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10093471588v10** e o código CRC **58a7afb0**.